

Anamnèse Pédiatrique

Anamnèse Actuelle

Plaintes et symptômes, chronologie, description,

Patient et parents contribuent selon capacités, possibilités

Anamnèse Personnelle

Grossesse et Accouchement, Période néonatale

Maladies, Hospitalisations, Chirurgie

Allergies, Vaccinations, Médicaments

Croissance et Développement

Nutrition, Alimentation

Anamnèse Familiale

Âges et santé mère, père, fratrie, vaccins

Maladies, Morts, Fausses-couches chez mère, Arbre généalogique

Anamnèse Sociale

Constellation familiale à domicile, Garde de l'enfant à l'extérieur

Habitat-type de logement, Organisation des chambres

Travail des parents, Niveau économique

Animaux domestiques, Exposition aux toxines, fumée

Revue des Systèmes

Fréquence Card

<1an	100-160
1-3	90-150
4-5	80-140
6-12	70-100
13-18	60-100

Fréquence Resp

<1an	30-60
1-3	24-40
4-5	22-34
6-12	18-30
13-18	12-20

Utilisez le coin de l'œil pour juger l'implantation des oreilles

TA	Syst min
Nné	60 mmHg
1-12mo	70
1-10an	70+ (2 x âge)
>10	90

Utilisez un centimètre

Triangle d'Évaluation Pédiatrique Observation à distance

A-Aspect-conscience, tonus, contact
B-Respiration-bruits, signes détresse resp
C-Hémodynamique-couleur, marbrure
Poids, Taille, PC + courbes. Percentiles
Vitaux : FR, FC, TA selon âge, Satu, T°

Tête et visage-dysmorphique, symétrie, sutures, fontanelles, yeux, oreilles, nez, palais, menton

ORL (**en dernier**), adénopathie, thyroïde, nez, bouche, langue, dents, palais, amygdales, conduit auditif externe, tympan

Resp : FR, tirage, battement des ailes du nez, balancement thoraco-abdominal, expirium actif, stridor, sibilances, gémissement, crépitations, percussion

Cardio : FC, rythme, B1B2, souffle, palpation thrill, point de choc, poul central et périphérique, temps de recoloration, température, hippocratisme digitale, foie

Abdo : symétrie, hernie, distension, bruits, hépato splénomégalie, masse, douleurs, défense, détente, percussion

Uro-Gen : Tanner stage, palpation rein, méat, testis, hernie, hydrocèle, vulve

Neuro : conscience, contact, pupilles, nerfs crâniens, 4 membres-tonus, motricité, force et coordination, sensibilité, réflexes ostéotendineux, tests cérébelleux, marche, signes méningés, fontanelle, développement

Musculo-squelettique : colonne-douleurs, symétrie, scoliose, articulations-œdème, érythème, douleurs, muscle-hypo ou hypertroph, douleurs

Peau : ictère, érythème, rash, T°, sudations, sècheresse, lésions, taches

Examen du status mental chez l'enfant et l'adolescent

Composante de l'examen du status mental	Repérer	Exemple
Apparence physique	- Âge (réel et représenté) - Vêtements appropriés par rapport à l'âge	« Stéphanie est une fille de 9 ans agréable à voir, bien apprêtée, portant des vêtements adaptés, qui fait plus que son âge (environ 12 ans) »
Ouverture relationnelle avec le clinicien, et tolérance à la séparation avec le parent	- Contact visuel - Coopération et adhésion à l'évaluation - Comportement envers les parents et la fratrie	« Elle évite le regard mais coopère lors de l'évaluation »
Humeurs, émotions	Type d'affects, adaptés ou non au contexte (ex déprimé, irritable, joyeux)	« Stéphanie semble déprimée (ex pleurs, absence de plaisir, désespoir), a peu de variations d'humeur et décrit une humeur dépressive »
Anxiété	- Peurs - Phobies - Obsessions - Compulsions ou rituels - Difficultés de séparation	« Elle ne présente pas de syndrome dépressif ou anxieux évidents »
Psychomotricité (agitation, ralentissement, ou décharges psychomotrices)	- Tics, maniérismes - Agitation psychomotrice - Coordination	« On observe un ralentissement psychomoteur »
Contenu et forme de la pensée	- Hallucinations - Délires - Troubles de la pensée	« On observe un ralentissement de la pensée, mais elle reste cohérente. On ne retrouve pas d'hallucinations ou de délire. »
Langage et discours	- Aisance - Prosodie - Allure - Capacités linguistiques	« Son discours est approprié par rapport à son âge »
Fonctionnement cognitif global	- Vocabulaire approprié - Soif de savoir - Dessins appropriés	« Ses capacités cognitives semblent altérées et son vocabulaire en dessous de son âge »
Attention et concentration	- Attention - Concentration	« Se fatigue très vite et s'arrête vite de suivre les conversations »
Mémoire	- Court-terme - Long-terme	« Ne montre pas de difficultés de remémoration »
Orientation	Orientation dans le temps, le lieu, les personnes	« A une bonne orientation spatio-temporelle »
Capacités de jugement et insight	- Conscience du problème - Capacité à critiquer des situations hypothétiques - Attitude vis-à-vis de l'aide - Observance	« Le patient a conscience du problème, est demandeur d'aide et de traitement »
Evaluation du risque	- Idées noires, comportement suicidaire - Comportement auto-agressif - Pensées hétéro-agressives ou projet de nuire à autrui - Comportement à risque	« Pas de risque auto ou hétéro-agressif »

16.11.2020

ENTRETIEN AVEC LES ADOLESCENTS

Poser le cadre de l'entretien

- Présentations (évt. « tu-vous »)
- Clarification de la séquence de l'entretien

Débuter l'entretien

Aborder la confidentialité

- Encourager la communication
- Expliquer les limites

Clarifier l'agenda et les attentes de l'adolescent·e

Anamnèse « générale »

- Caractérisation de(s) la plainte(s)
- Anamnèse par système dirigée
- Antécédents personnels, développement
- Croissance, puberté
- Filles : *ménarche, contraception, cycles menstruels*
- Anamnèse familiale
- Allergies, vaccinations, traitements
- Sommeil

Anamnèse « psychosociale »

CFVERSO

- Etat général
- Paramètres de croissance
Taille, poids, PC, BMI, vitesse de croissance
- Status cutané : acné ?
- Dépistage de la vue/de l'audition
- Status par système dirigé
ORL, thyroïde, CV, resp., digestif, neurologique
- Status locomoteur (dos !!!)
troubles statiques (scoliose p.ex)
- Status uro-génital (pas forcément 1^{ère} consultation – avec précaution !)
Stades pubertaires de Tanner

Quelques « trucs » généraux

- Attitude exempte de jugement
- Expliciter les transitions
 - *Expliquer pourquoi on pose les questions*
- Questions « ouvertes » avec temps suffisant pour les réponses
- Attitude professionnelle et respectueuse : ne pas être un « pote » !

Examen clinique

Conclure l'entretien

Faire un résumé

↓
Répondre à la plainte/aux questions

Définir ce qui sera transmis aux proches

Définir et organiser la suite de la prise en charge

- Violence psychologique et physique
- Accidents, traumatismes, blessures
- Bagarres
- Conduite sous l'influence de substances
- Sécurité dans les activités de loisirs

Points principaux à investiguer
Exemples de questions initiales :
 « ouvertes » à adapter à la situation

- Lieu de résidence et avec qui l'ado habite
 - Etat des relations avec proches
 - Personne(s) de confiance
 - Changements récents

Ex. : Où habites-tu et qui vit avec toi ?

- Santé mentale et suicide** // S
- Moral
 - Stress, anxiété
 - Tristesse, dépression
 - Idées noires, **idées suicidaires**
 - Comportements auto-agressifs
 - Isolement social, perte d'intérêt
 - **Attention : fatigue peut être le signe d'une dépression**

- Sexualité** // S
- Relations
 - Rapports sexuels : plaisir ? Questions ?
 - Orientation sexuelle : **rester neutre !**
 - Contraception, connaissances IST
 - Violence sexuelle passée/actuelle
 - « Sexting » Ex. : As-tu une relation amoureuse ?

Ex. : Certains jeunes expérimentent certaines substances, est-ce ton cas ou celui de tes amis ?

- Drogues** // D
- Tabac, alcool
 - Cigarette électronique
 - Cannabis, autres drogues
 - **Préciser : fréquence, intensité, contexte, raisons évoquées, consommation seul ou en groupe, etc.**
 - Dépendances dans la famille

ANAMNESE PSYCHOSOCIALE HEAADSSS



- Alimentation** // A
- Image corporelle
 - Evolution du poids
 - Régimes entrepris
 - Restriction, binge-eating
 - Compensation (vomissements, sport etc.)
 - Description d'une journée type

Ex. : Que penses-tu de ton poids / de ton corps ?

- Education** // E
- Parcours scolaire
 - Situation actuelle
 - Notes, matières préférées
 - Relations avec pairs et profs, harcèlement
 - Absentéisme, changements récents
 - Projets d'avenir
- Ex. : Parle-moi de ta situation à l'école / au travail

- Activités** // A
- Amis, meilleur(e) ami(e)
 - Activités avec amis et famille
 - **Ecrans** : TV, ordinateur, jeux, smartphone
 - Sport, hobbies, activités créatives
- Ex. : Qu'est-ce que tu fais pour t'amuser / avec tes amis ?

Habitat // H

Sécurité // S